UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

SUJET 4 UROLOGIE
HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE
Avec patient simulé
Sans geste clinique

Rédacteur : GAGLIARDI Chloé **Date de rédaction : Décembre 2023**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N°23 – Anomalie de la miction

Domaine de compétence principal : Entretien/interrogatoire

Domaine de compétence secondaire : Stratégie diagnostique

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1- Chercher les éléments permettant d'orienter vers une cause urologique ou extra-urologique
2- Différencier les symptômes de la phase de stockage, de vidange, et post-mictionnelle

Objectifs de la station (items de connaissances abordés) :

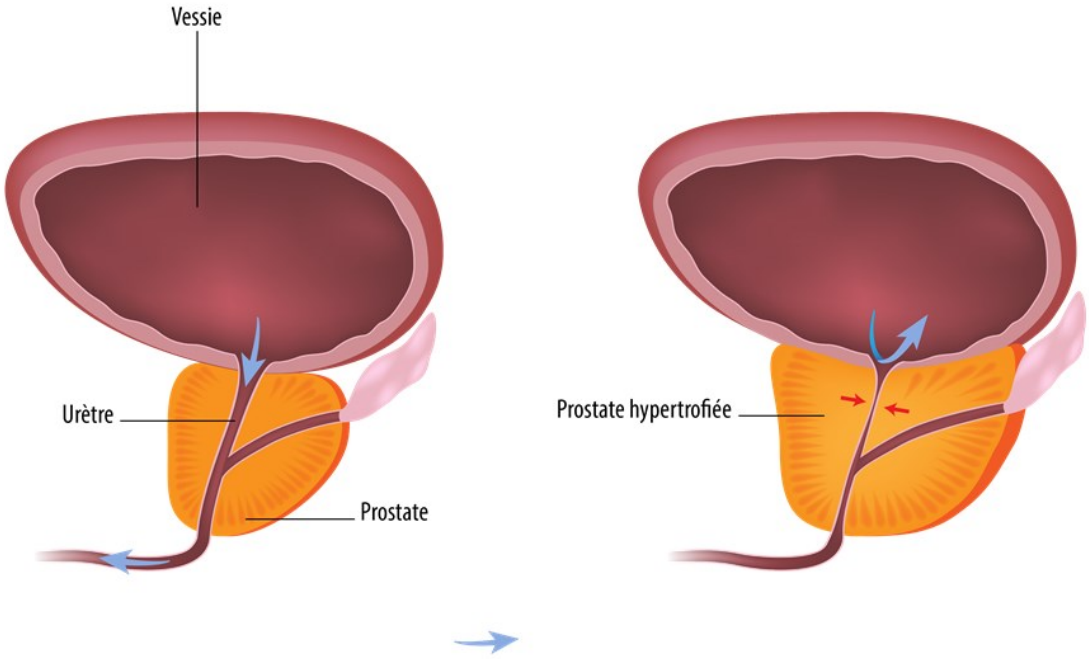
1. Item 125 : Troubles de la miction et incontinence urinaire de l'adulte et du sujet âgé
2. Item 127 : Hypertrophie bénigne de la prostate

Patient simulé nécessaire à la station : OUI sexe masculin de plus de 60 ans

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- 1 table, 2 chaises, 1 feuille blanche (pour le schéma)

Exemple de schéma



UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Instructions au patient simulé

Rappel : seules les réponses précisées ci-dessous et les instructions peuvent être verbalisées. Le patient simulé ne doit rien dire d'autres que ce qui est précisé.

Synopsis : (décrivez en quelques lignes ici le résumé du rôle et précisez s'il y a un contact physique ou non)

Ex : Vous vous appelez Monsieur GILBERT Serge, vous avez 65 ans et vous êtes retraité depuis peu. Vous avez travaillé dans l'administration de la faculté. Vous avez depuis quelques mois des problèmes pour uriner, ce qui vous gêne dans votre vie quotidienne. Vous venez voir votre médecin généraliste car ces problèmes ne semblent pas s'améliorer.
C'est l'interne de votre médecin qui vous reçoit aujourd'hui. Il va vous interroger.

Identité/Contexte (éléments indispensables)	Nom : M GILBERT / Prénom : Serge Age : 65 ans Retraité, administration de la faculté Marié, 2 enfants Appartement en centre-ville de Nice
Antécédents	Aucun
Médicaments actuels/ Toxiques	Aucun Pas de tabac
Etats d'esprit/ comportement	Posture : assis Douleur : aucune pendant la consultation Angoisse : faible
Déroulement du scénario	Vous êtes assis calmement. Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par : *Ex : "Je viens vous voir car j'ai des problèmes pour uriner. Je ne voulais pas venir pour quelque chose comme ça mais ça commence à me gêner »* Puis répondez aux questions de l'étudiant (cf tableau ci-dessous) et ne dévoilez les informations que s'il vous les demande spécifiquement. Ex : Si l'étudiant vous demande de décrire vos symptômes urinaires, vous répondrez : « Je ne sais pas, c'est difficile à décrire » (vous attendrez des questions plus précises)

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Vous ne répondrez aux questions suivantes que si l'évalué (étudiant-médecin) vous les pose. Si les questions de l'étudiant-médecin ne sont pas listées ci-dessous, répondre « je ne sais pas ».

Questions éventuellement posées par l'étudiant - médecin	**Réponses à donner par le patient simulé**
Utiliser un vocabulaire simple sans jargon médical *Si les questions sont compliquées le patient doit dire : « Comment ? Je ne comprends pas la question. »*	
Quand est-ce que ça a commencé ?	Ça fait quelques mois, 5 mois environ
Est-ce que c'est arrivé brutalement ou progressivement ?	Progressivement
Comment est-ce que ça a évolué ?	Ça devient de plus en plus fréquent
Est-ce que vous allez plus souvent uriner qu'avant ?	Oui
Est-ce que vous êtes réveillé la nuit par l'envie d'uriner ?	Oui, mais pas toutes les nuits
Est-ce que vous avez du mal à arriver jusqu'aux toilettes lorsque vous avez envie d'uriner ? / du mal à vous retenir d'uriner ?	Non
Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des pertes d'urines involontaire ?	Non
Est-ce que vous avez des interruptions du jet d'urine / jet haché ?	Oui parfois
Est-ce que vous avez besoin de forcer / pousser pour commencer à uriner ?	Oui, à chaque fois
Est-ce que vous avez une diminution de la taille / force du jet d'urine ?	Oui
Est-ce que vous avez la sensation que votre vessie n'est pas complètement vidée après avoir uriné ?	Oui
Est-ce que vous avez des gouttes retardataires / retour d'urine juste après la fin de la miction ?	Oui, ça arrive
Est-ce que vous avez du sang dans les urines ?	Non, jamais
Est-ce que ça vous brûle / c'est douloureux quand vous urinez ?	Non
Est-ce que vous avez de la fièvre / des frissons ?	Non
Est-ce que vous avez une dysfonction sexuelle / troubles de l'érection / de l'éjaculation / troubles de la libido ?	Non
Est-ce que vous avez eu un traumatisme / une infection urinaire récente ?	Non

Est-ce que vous avez des maladies / antécédents médicaux à signaler ?	Je ne crois pas …
Est-ce que vous avez une **maladie neurologique / sclérose en plaque / maladie de Parkinson / AVC** ?	Non
Est-ce qu'il y a des antécédents de maladie dans votre famille ?	Oui, comme dans toutes les familles
Est-ce qu'il y a des antécédents **de cancer** dans votre famille ?	Non
Est-ce que vous avez déjà eu des opérations ?	Non
Est-ce que vous avez des allergies ?	Non, aucune
Est-ce que vous prenez des traitements ?	Non
Est-ce que vous avez des douleurs en dehors des mictions ?	Non

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne en médecine générale en cabinet de ville. Vous recevez Mr GILBERT, 65 ans, qui présente des symptômes urinaires le gênant dans son quotidien.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Faire l'interrogatoire ciblé des symptômes du patient
2. Enoncer l'hypothèse diagnostique la plus probable
3. Expliquer au patient pourquoi ce diagnostic donne des symptômes urinaires, vous réaliserez un schéma explicatif.

Vous n'avez pas à réaliser d'examen physique

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Recherche des signes urinaires de la phase de remplissage : 1/ pollakiurie diurne, 2/ urgenturie, 3/ nycturie, 4/ incontinence urinaire (FAIT si au minimum 3 signes sont recherchés)	
Recherche des signes urinaires de la phase mictionnelle : 1/ retard à l'initiation de la miction, 2/ jet faible, 3/ interruption de la miction ou jet haché, 4/ miction par poussée abdominale (FAIT si au minimum 3 signes sont recherchés)	
Recherche des signes de la phase post-mictionnelle : 1/ gouttes retardataires, 2/ sensation de vidange vésicale incomplète (FAIT si au minimum 1 signe est recherché)	
Recherche la présence d'hématurie	
Recherche la présence de brûlures mictionnelles	
Recherche la présence de fièvre / frissons	
Recherche les antécédents de cancers (personnels ou familiaux)	
Recherche les antécédents personnels de troubles neurologiques	
Tache 2	
Enonce le diagnostic d'hypertrophie bénigne de la prostate	
Tache 3	
Réalise un schéma explicatif : FAIT si au minimum présence de la prostate, de l'urètre et de la vessie (cf schéma exemple)	
Explique qu'il y a une augmentation de la taille / du volume de la prostate	
Explique que ça provoque une obstruction de l'urètre	
Explique que ça provoque un ralentissement / une difficulté du flux lors de la miction	
Explique que ça peut provoquer un résidu post-mictionnel	
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à écouter	1 à 5
Aptitude à questionner	
Aptitude à fournir les renseignements au patient	
Communication non verbale	

UTILISER IMPERATIVEMENT DES VERBES d'ACTION ex : « Dit » « Énonce » « Palpe » « Écoute »
SEPARER CHAQUE ITEM (ex : « recherche une consommation de tabac » et « quantifie une consommation de tabac » sont deux items différents)

MAXIMUM 15 Items de compétence spécifiques et 5 items de compétences génériques
Choisir les plus pertinents/discriminants

Fournir des schémas pour les points cliniques à évaluer par l'examinateur (cadrans d'examen abdominal, foyers d'auscultation etc.)

Préciser quand l'examinateur doit intervenir pour donner un signe clinique positif

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Recherche des signes urinaires de la phase de remplissage : 1/ pollakiurie diurne, 2/ urgenturie, 3/ nycturie, 4/ incontinence urinaire (FAIT si au minimum 3 signes sont recherchés)	5
Recherche des signes urinaires de la phase mictionnelle : 1/ retard à l'initiation de la miction, 2/ jet faible, 3/ interruption de la miction ou jet haché, 4/ miction par poussée abdominale (FAIT si au minimum 3 signes sont recherchés)	5
Recherche des signes de la phase post-mictionnelle : 1/ gouttes retardataires, 2/ sensation de vidange vésicale incomplète (FAIT si au minimum 1 signe est recherché)	5
Recherche la présence d'hématurie	5
Recherche la présence de brûlures mictionnelles	5
Recherche la présence de fièvre / frissons	3
Recherche les antécédents familiaux de cancers	4
Recherche les antécédents personnels de troubles neurologiques	2
Tache 2	
Enonce le diagnostic d'hypertrophie bénigne de la prostate	5
Tache 3	
Réalise un schéma explicatif : FAIT si au minimum présence de la prostate, de l'urètre et de la vessie (cf schéma exemple)	5
Explique qu'il y a une augmentation de la taille / du volume de la prostate	2
Explique que ça provoque une obstruction de l'urètre	2
Explique que ça provoque un ralentissement / une difficulté du flux lors de la miction	1
Explique que ça peut provoquer un résidu post-mictionnel	1
	/50
COMPETENCES GENERIQUES	
Aptitude à écouter	1 à 5
Aptitude à questionner	1 à 5
Aptitude à fournir les renseignements au patient	1 à 5
Communication non verbale	1 à 5
Note totale	/60